

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE IMPRESIÓN CLÍNICA GLOBAL (CGI)

Eje IV: Funcionamiento y Severidad • Escala Heteroaplicada Transdiagnóstica de Severidad y Respuesta Terapéutica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Impresión Clínica Global (CGI: Subescalas CGI-S y CGI-I).
Nombre Original	Clinical Global Impressions Scale (CGI; Guy, 1976; NIMH).
Autor Original	Dr. William Guy, Ph.D. (Early Clinical Drug Evaluation Unit - ECDEU, NIMH, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Uso clínico y regulatorio universal en psiquiatría y salud mental en España y Latinoamérica.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento, Gravedad y Evolución. Juicio clínico sintomático transdiagnóstico.
Tipo de Instrumento	Escala de heteroestimación clínica rápida de 1 reactivo de severidad y 1 reactivo de mejoría.
Población y Rango	Niños, adolescentes y adultos con cualquier patología psiquiátrica o neuropsicológica.
Tiempo de Administración	1 a 2 minutos inmediatamente tras la entrevista clínica habitual.
Régimen de Licencia	Dominio público gubernamental (NIMH) / Uso clínico y en investigación libre sin costo.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL JUICIO CLÍNICO GLOBAL TRANSDIAGNÓSTICO

La **Escala de Impresión Clínica Global (CGI)**, formulada en 1976 dentro del programa de psicofarmacología del National Institute of Mental Health (NIMH), es una de las herramientas más extendidas en la práctica clínica y el estándar de oro en ensayos clínicos regulatorios (aprobaciones FDA y EMA). Su fundamentación epistemológica radica en la **sólida validez ecológica del juicio clínico experto**:

- Carácter Transdiagnóstico:** A diferencia de escalas sindrómicas específicas (HAM-D para depresión o PANSS para psicosis), la CGI permite cuantificar la severidad global y la evolución longitudinal independientemente del diagnóstico nosológico.
- Integración Holística de la Disfunción:** El evaluador sintetiza en una escala unificada la intensidad de los síntomas, la alteración del funcionamiento psicosocial y ocupacional, y el nivel de sufrimiento subjetivo manifestado por el consultante.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (CGI-S, CGI-I Y EFICACIA)

El protocolo de la CGI consta de dos reactivos principales complementados por un índice de eficacia terapéutica:

Subescala CGI	Rango Métrica	Definición Operativa y Criterios Clínicos Evaluados
1. Severidad Global (CGI-S)	Escala 1 a 7 pts	Evalúa la gravedad actual del cuadro psiquiátrico en los últimos 7 días respecto al cuadro típico.
2. Mejoría Global (CGI-I)	Escala 1 a 7 pts	Cuantifica el cambio clínico experimentado desde el inicio del tratamiento actual (línea base).
3. Índice de Eficacia	Matriz 4 × 4	Cruza el efecto terapéutico (nulo a excelente) con la interferencia de efectos secundarios.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO CLÍNICO EN ESPAÑA / LATAM

Décadas de aplicación clínica e investigación en salud mental en España y Latinoamérica confirman su robustez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Interjueces	CCI $r = 0.75 - 0.90$	Excelente concordancia entre profesionales cuando se basan en criterios de anclaje.
Sensibilidad al Cambio	Tamaño efecto $d = 0.85$	Una de las escalas más sensibles a la respuesta terapéutica psicoterapéutica y farmacológica.
Validez Convergente (Depresión)	$r = 0.70 - 0.85$ (HDRS / BDI)	Correlación casi idéntica con escalas psicométricas extensas de depresión.
Validez Convergente (Psicosis)	$r = 0.74 - 0.82$ (PANSS / BPRS)	Alta convergencia con la severidad psicótica medida por PANSS total.
Criterio Regulatorio	Estándar de Oro	Variable de eficacia primaria o coprimaria obligatoria en agencias reguladoras internacionales.

5. REGLAS DE APLICACIÓN Y NIVELES DE ANCLAJE CLÍNICO

- **Subescala de Severidad Clínica (CGI-S):** “¿Cuál es la gravedad de la enfermedad del paciente en este momento considerando su experiencia total con esta población clínica?”:
 - **1:** Normal, no enfermo (ausencia de síntomas patológicos).
 - **2:** Dudoso / En el límite de enfermedad psiquiátrica.
 - **3:** Levemente enfermo (síntomas presentes con mínima interferencia funcional).
 - **4:** Moderadamente enfermo (síntomas evidentes y notable interferencia laboral/social).
 - **5:** Notablemente enfermo (marcada disfunción y sufrimiento agudo).
 - **6:** Gravemente enfermo (incapacidad para el autocuidado o conducta desorganizada).
 - **7:** Entre los pacientes más extremadamente enfermos (riesgo vital inmediato o psicosis catatónica).
- **Subescala de Mejoría Clínica Global (CGI-I):** “¿Cómo ha evolucionado el paciente comparado con su estado al iniciar el tratamiento actual?”:
 - **1 = Mucho mejor (Muy mejorado); 2 = Bastante mejor; 3 = Levemente mejor; 4 = Sin cambios; 5 = Levemente peor; 6 = Bastante peor; 7 = Mucho peor.**

6. CRITERIOS DE RESPUESTA, REMISIÓN Y ESTRATIFICACIÓN EVOLUTIVA

Resultado Clínico	Criterio CGI-I	Criterio CGI-S	Implicación en Guías de Práctica Clínica
Remisión Completa	1 (Mucho mejor)	1 o 2 (Normal / Dudoso)	Restitución ad integrum; consolidación del plan de mantenimiento.
Respuesta Terapéutica	1 o 2 (Mucho/Bastante)	Descenso ≥ 2 niveles	Criterio regulatorio internacional de respuesta positiva al tratamiento.
Respuesta Parcial	3 (Levemente mejor)	Descenso de 1 nivel	Eficacia insuficiente; requiere ajuste de dosis o combinación terapéutica.
Sin Respuesta / Falla	4 a 7 (Sin cambio/Peor)	Sin cambio o aumento	Fracaso terapéutico; revisar diagnóstico y cambiar estrategia.

DEFINICIÓN CONSENSUADA DE RESPUESTA CLÍNICA POSITIVA (CGI-I ≤ 2):

En consensos internacionales de psiquiatría y psicología clínica, se define que un paciente es **respondedor terapéutico** si y solo si obtiene una puntuación en CGI-I de **1 (Mucho mejor)** o **2 (Bastante mejor)**. Una calificación de 3 (Levemente mejor) se considera respuesta no satisfactoria.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS

PROTOCOLO SECUENCIAL DE SEGUIMIENTO CON CGI:

- **Paso 1 (Registro de Línea Base):** Evaluar CGI-S en la visita de evaluación diagnóstica.
- **Paso 2 (Evaluación a las 4-6 Semanas):** Registrar CGI-S y CGI-I.
 - Si CGI-I es 1 o 2: Mantener la pauta terapéutica sin modificaciones precipitadas.
 - Si CGI-I es 3: Analizar cumplimiento terapéutico y considerar optimización de dosis o frecuencia de sesiones.
 - Si CGI-I es ≥ 4 : Declarar fracaso del esquema terapéutico inicial.
- **Paso 3 (Evaluación del Índice de Eficacia):** Si la mejoría se acompaña de efectos adversos intolerables (que superan la ganancia terapéutica), suspender o sustituir la intervención.
- **Paso 4 (Criterio de Alta o Mantenimiento):** Cuando CGI-S se mantenga en 1 o 2 durante al menos 6 meses consecutivos, programar la reducción gradual de intervenciones hacia el alta clínica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SEGUIMIENTO EN TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR GRAVE

Identificación: Mujer de 52 años, profesora de secundaria, acude a consulta de psiquiatría acompañada por su esposo con cuadro de 3 meses de evolución de anhedonia completa, inhibición psicomotriz, pérdida de 8 kg de peso e ideas de ruina y desesperanza tras el fallecimiento de su madre.

Visita Basal (Semana 0):

• **CGI-S = 6 / 7 puntos (Gravemente enferma).** Incapacidad absoluta para realizar tareas domésticas y laborales; ideación de muerte pasiva constante. Se inició tratamiento con Venlafaxina retard y psicoterapia de activación conductual.

Visita de Seguimiento (Semana 4):

• **CGI-S = 5 / 7** (Notablemente enferma); **CGI-I = 3 / 7** (Levemente mejor). Presenta leve mejoría motriz pero persiste marcada tristeza. Se optimizó dosis farmacológica.

Visita de Seguimiento (Semana 12):

• **CGI-S = 2 / 7 (Dudoso / Límite de enfermedad); CGI-I = 1 / 7 (Mucho mejor / Remisión).**

Resultado Clínico: La paciente recuperó su patrón de sueño y apetito, retomó el contacto con amistades y se reincorporó a la docencia con total funcionalidad y afecto eutímico reactivo preservado.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SUBJETIVIDAD Y FALTA DE ANCLAJE:

Al carecer de ítems específicos, la CGI puede sufrir sesgo si no se usan los criterios de anclaje de la ECDEU. Dos clínicos inexpertos pueden discrepar ampliamente en CGI-S 4 vs 6.

DISOCIACIÓN SÍNTOMA-FUNCIONAMIENTO:

Un paciente psicótico puede presentar delirios encapsulados (síntoma grave) manteniendo buena autonomía laboral. Ponderar ambos factores al asignar el nivel de CGI-S.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Guy, W. (1976). *ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology* (DHEW Publication No. ADM 76-338, pp. 218-222). National Institute of Mental Health.
2. Busner, J., & Targum, S. D. (2007). The Clinical Global Impressions scale: Applying a research tool in clinical practice. *Psychiatry (Edmont)*, 4(7), 28-37.
3. Haro, J. M., et al. (2003). The Clinical Global Impression-Schizophrenia scale: A simple instrument to measure the diversity of symptoms present in schizophrenia. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 107(s416), 16-23.
4. Kadouri, A., Corruble, E., & Falissard, B. (2007). The validity of the Clinical Global Impression-Severity scale in the assessment of depression. *Psychiatry Research*, 152(2-3), 229-238.